

Накладання коміра Шанца

1. Сценарій. У приймальне відділення надійшов пацієнт з ротаційним підвивихом хребця С1 (атланта). Необхідно накласти комір Шанца.

перелік медичного обладнання (багаторазового використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість
1	Комір Шанца	1 шт.

- перелік витратних матеріалів (одноразове використання)

№ п/п	Перелік медичного обладнання	Кількість на 1 спробу	Кількість на 10 спроб
1	Стерильні марлеві серветки	2 шт	20 шт
3	Антисептичний розчин (70% розчин етилового спирту)	10 мл	100 мл
5	Медичні стерильні рукавички	1 пара	10 пар
6	Захисна медична маска	1 шт	10 шт



№ п/п	Маніпуляція	Форма представлення
1	Коректне розташування пацієнт-лікар, провести огляд постраждалого, визначити наявність свідомості та дихання.	Сказати
2	Встановлення контакту з пацієнтом. Привітатись, представитись, позначити свою роль. Попросити пацієнта представитись. Визначити особливості анамнезу (механізм травми, алергічні реакції на ліки)	Сказати
3	Отримати інформаційну згоду на проведення маніпуляції (пояснити хід та мету процедури)	Сказати
4	Одягнути медичні рукавички, маску.	Виконати

5	Оглянути місце травми для визначення характеру ушкодження (обережно, не повертаючи голову пацієнта)	Виконати, Сказати.
6	Підготувати комір Шанца до накладення, розгорнувши його	Виконати,
7	Осушити та очистити шкіру пацієнта в області шиї серветкою з антисептиком (обережно)	Виконати, Сказати
8	Коректно та обережно встановити комір проводячи його рукою під шиєю так, щоб нижній край коміра спереду був на рівні ключиць, а верхній вирізкою на рівні підборіддя. Ззаду шия повинна знаходитися на середині коміра, а верхній край коміра знаходиться під потилицею. Нижній край коміра знаходиться під трапецієвидним м'язом.	Виконати
9	Перевірити правильність накладання: між коміром та шиєю пацієнта має проходити палець. Зафіксувати застібками.	Виконати, Сказати
10	Повідомити хворого про результати іммобілізації та подальші дії	Сказати
11	Уточнити у пацієнта його самопочуття (у т.ч. рухливість та чутливість кінцівок).	Сказати
12	Запропонувати пацієнтові залишитися у зручному положенні на кушетці.	Сказати
13	Завершення процедури	Сказати

Діагностика

3.1. Оцінка правильності накладання шийного коміра

Сказати: «Оцінюю правильність накладання шийного коміра: шия фіксована, рухомість обмежена. Між коміром і шиєю проходить один палець — це свідчить про достатню іммобілізацію без надмірного стискання.»

3.2. Оцінка характеру неврологічних змін після накладання (відсутність)

Сказати: «Повторно оцінюю неврологічний статус: активні та пасивні рухи, м'язова сила, чутливість у верхніх та нижніх кінцівках збережені повністю. Патологічні рефлексії не виявлені. Після фіксації коміром нових неврологічних симптомів не виникло.»

4. Визначення тактики ведення та лікування

4.1. Необхідність додаткових методів дослідження (рентгенографія)

Сказати: «Для уточнення характеру травми показано рентгенографію шийного відділу хребта в 2 проєкціях. У разі сумнівних даних — КТ або МРТ шийного відділу. Це дозволить виключити переломи, підвивихи або інші пошкодження шийних хребців.»

4.2. Призначення медикаментозних засобів

Сказати: «Призначаю симптоматичне лікування:

- нестероїдні протизапальні препарати для зменшення болю та м'язового спазму (наприклад, ібупрофен);
- міорелаксанти — за потреби;
- контроль загального стану в динаміці;
- тимчасове обмеження фізичного навантаження.

Пацієнту рекомендовано амбулаторне спостереження травматолога або невропатолога.»